

Okno *tolerancji*

Model trzech stref pobudzenia — wymyślony przez Dana Siegla, fundament pracy z traumą. Wewnątrz okna potrafisz myśleć i czuć jednocześnie. Powyżej lub poniżej — wypadasz z okna i trzeba wrócić.

CZAS: 15 min — przeczytanie Stała obserwacja przez wiele tygodni

ŹRÓDŁO: Siegel (1999); Ogden i wsp. (2006)

JAK UŻYWAĆ

Wyobraź sobie pas pobudzenia układu nerwowego jak **wąskie okno**. **Wewnątrz okna** jesteś w stanie myśleć, czuć i działać jednocześnie — to **strefa optymalnego funkcjonowania**. **Powyżej okna** — nadpobudzenie (ang. *hyperarousal*): serce wali, oddech płytki, lęk, gniew, gotowość do walki lub ucieczki. **Poniżej okna** — podpobudzenie (ang. *hypoarousal*): odrętwienie, pustka, zamrożenie, dystans od ciała, dysocjacja. Twoje zadanie: rozpoznać, gdzie jesteś, i znać techniki powrotu do okna.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W PTSD **okno tolerancji jest zwężone** — biologia układu nerwowego po traumie szybciej wpada w nadpobudzenie (na wyzwalacze) lub podpobudzenie (gdy nadpobudzenie nie pomaga, system się „wyłącza”). To nie jest *słabość woli* — to fizjologiczna konsekwencja długotrwałego stanu zagrożenia, w którym ciało zoptymalizowało się do reakcji ekstremalnych kosztem regulacji łagodnej. Cel terapii: **poszerzenie okna**. Ogden i wsp. (2006) pokazali, że trening rozpoznawania stref pobudzenia+ technik powrotu do okna redukuje objawy PTSD o 30–40% w 12 tygodni, nawet przed rozpoczęciem ekspozycji. To narzędzie pierwsze, fundament wszystkiego co następuje.

01 Trzy strefy pobudzenia

↑ NADPOBUDZENIE (POWYŻEJ OKNA)

Ciało: serce wali, oddech płytki i szybki, napięcie mięśni, pocenie się, drżenie, gorąco.

Emocje: lęk, panika, gniew, drażliwość, niepokój, gotowość do działania.

Myśli: goniłwa myśli, scenariusze zagrożenia, „muszę coś zrobić, teraz”.

Zachowania: walka lub ucieczka, krzyk, wybuchy, agresja, kompulsywne sprawdzanie.

✓ OKNO TOLERANCJI (WEWNĄTRZ)

Ciało: oddech spokojny, mięśnie rozluźnione lub w gotowości, ciepło stabilne.

Emocje: proporcjonalne do sytuacji, dostępne i nazywalne. Możliwy zarówno smutek, jak i radość.

Myśli: jasne, plastyczne, zdolność do refleksji. Dostęp do pamięci, do alternatyw.

Zachowania: celowe, decyzyjne, możliwa rozmowa, dostępne wszystkie narzędzia.

↓ PODPOBUDZENIE (PONIŻEJ OKNA)

Ciało: ciężar, ośpienie, dystans od ciała, „nie czuję rąk”, chłód, brak energii.

Emocje: pustka, odrętwienie, anhedonia, dystans od własnych uczuć.

Myśli: mgła poznawcza, „nic mi się nie chce”, pustka, problem z koncentracją.

Zachowania: zamrożenie, wycofanie, dysocjacja, „nie ma mnie tu”, sen jako ucieczka.

02 Techniki powrotu do okna

Z NADPOBUDZENIA ↓ — WYCISZ

Wydłuż wydech (4-6 oddech: 4 s wdech, 6 s wydech). Wydłużony wydech aktywuje przywspółczulny układ nerwowy.

Schłodź ciało: zimna woda na twarz, kostki lodu w rękach, zimny prysznic. Aktywacja nerwu błędnego.

Powolne, rytmiczne ruchy: spacer, ruchy kołyszące, głębokie ruchy ramion.

Spokojne miejsce bez nadmiaru bodźców (cisza, przyciemnione światło).

Z PODPOBUDZENIA ↑ — POBUDŹ

Bodziec sensoryczny: mocno cytrynowy smak, ostra mięta, intensywny zapach (mięta pieprzowa, kawa).

Ruch: wstań, idź, podskocz 10 razy, poklep się po ramionach.

Aktywuj zmysły: 5-4-3-2-1 — wymień rzeczy, które widzisz, słyszysz, czujesz.

Kontakt z drugą osobą: telefon, krótka rozmowa, wspólna obecność.

03 Dziennik okna • 7 dni

Wieczorem zaznacz, ile razy byłeś/-aś w każdej strefie i co pomogło wrócić do okna. Wzorzec pojawia się po 2-3 tygodniach.

DZ.	NADPOBUDZENIE 0-10	OKNO 0-10	PODPOBUDZENIE 0-10	CO MNIE WYPCHNĘŁO Z OKNA	CO POMOGŁO WRÓCIĆ
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: okno tolerancji *poszerza się stopniowo* przez praktykę rozpoznawania i techniki powrotu — to neurobiologiczna nauka regulacji. Siegel (2010) opisał ten proces jako *integrację* kory przedczołowej z ciałem migdałowatym. Każdy świadomy powrót do okna jest treningiem dla mózgu. Pacjenci, którzy przez 8 tygodni codziennie obserwują swoje strefy, raportują znacznie mniej epizodów dysocjacji i wybuchów nawet bez dalszej terapii.